

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZUNG	Notfallstandard Atemnot	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition:

Atemnot ist ein vom Bewohner bedrohlich empfundener Luftmangel. Viele Betroffene leben seit vielen Jahren mit dieser Gesundheitseinschränkung und erhalten ggf. Sauerstoff etwa über mobile Sauerstoffsysteme.

Als Fachbegriffe für Atemnot sind üblich:

- **Dyspnoe:** Das subjektive Empfinden von Atemnot bei erschwelter Atmung
- **Belastungsdyspnoe:** Atemnot bei körperlicher Anstrengung
- **Ruhedyspnoe:** Atemnot auch im Ruhezustand
- **Orthopnoe:** Ist die höchste Stufe der Atemnot. Die Atemnot kann gerade nur so in aufrechter Körperhaltung und mit Hilfe der Atemhilfsmuskulatur ausgeglichen werden
- **Apnoe:** Atemstillstand. Sofortige Wiederbelebensmaßnahmen sind erforderlich

Atemnot wird abhängig von der Schwere der Symptome in vier Grade eingeteilt:

- **Grad 1:** Die Atemnot tritt nur bei entsprechender körperlicher Belastung auf, z.B. beim Treppensteigen, beim Tragen schwerer Lasten oder beim schnelleren Gehen
- **Grad 2:** Die Atemnot tritt schon bei mittlerer körperlicher Beanspruchung auf, z. B. schon beim Spazierengehen auf ebener Strecke
- **Grad 3:** Die Atemnot tritt schon bei geringer körperlicher Belastung auf, z.B. beim An- und Ausziehen von Bekleidung)
- **Grad 4:** Die Atemnot tritt auch im Ruhezustand auf, z.B. im Liegen, Sitzen

Atemnot tritt insbesondere bei schweren Grunderkrankungen häufiger auf. Betroffen von Atemnot sind vor allem:

- 50% aller Bewohner mit einem fortgeschrittenen Tumorleiden
- 70% aller Bewohner mit Lungentumoren
- 80% aller sterbender Bewohner in den letzten 24 Lebensstunden

1. Ziel:

- Der Bewohner atmet wieder normal
- Der Bewohner ist entspannt und angstfrei
- Der Bewohner weiß, dass ihm bei Atemnot schnell und professionell geholfen wird
- Der Bewohner kennt atemunterstützende Körperhaltungen und Techniken, die das Atmen erleichtern. Er wendet diese bei einer Attacke an

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN. WIR SCHUTZEN.	Notfallstandard Atemnot	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

2. Anwendungsbereich:

Symptome:

- Der Bewohner atmet sehr schnell und oberflächlich
- Es kommt zum „Nasenflügelatmen“ (heftige Bewegung der Nasenflügel)
- Es sind Atemgeräusche hörbar, z.B. Brummen, Giemen, Ziehen oder Pfeifen, ggf. hustet der Bewohner
- Der Puls des Bewohners ist erhöht
- Es bildet sich eine Zyanose (Blaufärbung durch Sauerstoffunterversorgung), etwa an den Lippen oder Nägeln
- Der Bewohner klagt über ein Erstickungsgefühl, ein Beklemmungsgefühl oder Schmerzen im Brustkorb
- Der Bewohner klagt über ein Kältegefühl
- Der Bewohner hat offenbar extreme Angst, der Gesichtsausdruck ist verzerrt
- Der Bewohner schwitzt stark
- Die Körperhaltung des Bewohners ist angespannt oder verkrampft
- Der liegende Bewohner richtet den Oberkörper auf und nutzt die Atemhilfsmuskulatur. Ggf. stützt der Bewohner die Arme auf
- Der stehende Bewohner geht in die „Torwartstellung“. Er stützt die gestreckten Arme auf die Oberschenkel. Alternativ stemmt der Bewohner eine Hand in die Hüften und stützt sich mit der anderen Hand an der Wand ab
- Der Bewohner hustet, ggf. mit Auswurf

3. Durchführung und Zuständigkeiten:

Maßnahmen bei akuter Atemnot:

- Wenn hinreichende Anzeichen für eine Gesundheitsgefährdung vorliegen, wird umgehend der Hausarzt oder Notarzt gerufen (**Rufnummer: 0-112**)
Ein Merkmal hierfür ist das Auftreten einer Zyanose (z.B. Blaufärbung der Lippen oder Fingerspitzen durch Sauerstoffmangel)
- Eine Pflegekraft bleibt immer beim Bewohner und versucht beruhigend auf diesen einzuwirken, denn Angst verschlimmert die Symptomatik, die dann noch mehr Angst auslöst.
- Die Pflegekraft ermittelt die Vitalwerte, vor allem **Blutdruck, Puls und Atemfrequenz**, sowie die Hautfarbe (blass, bläulich oder gräulich)
- Sofern eine Bedarfsmedikation vorliegt, wird diese dem Bewohner verabreicht (nach AVO Dosieraerosol, Spray, Tabletten etc.)
- Wenn eine ärztliche Anordnung vorliegt, erhält der Bewohner Sauerstoffgaben, je nach AVO
- Ggf. das Fenster öffnen
- Ggf. wird der Bewohner abgesaugt
- Je nach Toleranz des Bewohners wird dieser in eine atemerleichternde Position gebracht
- Einengende Kleidung lockern oder entfernen
- Ggf. auf Wunsch des Bewohners, Besucher aus dem Zimmer bitten
- Ggf. durch ableckende Gesprächsführung den Bewohner beruhigen, dabei soll der Bewohner aber nicht zu viel sprechen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZUNG	Notfallstandard Atemnot	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Die Pflegekraft leitet den Bewohner zu atemerleichternden Übungen an (z.B. durch die Nase einatmen und mit der „Lippenbremse“ ausatmen)

Maßnahmen bei Schmerzen:

Die Pflegekraft fragt den Bewohner ob und wo er Schmerzen hat.
Wichtig sind hier folgende Fragen:

- Wo** genau tritt der Schmerz auf?
- Welche** Umstände lösen den Schmerz aus oder wodurch wird der Schmerz verstärkt?
- Wie** lange dauert der Schmerz an? Minuten, Stunden oder Tage?
- Welcher** Art ist der Schmerz? Ziehend, pochend, schneidend, stechend usw.

Lagerung:

- Bei einer Linksherzinsuffizienz wird bei älteren Menschen überwiegend die Oberkörperhochlagerung bevorzugt
- Eine Halbmondlage bewirkt eine Dehnung des oberen Lungenbereiches. So wird also diese Sektion besser belüftet
- V- und A-Lagerung. Wenn der Bewohner in eine V-Lagerung gebracht wird, werden die unteren Lungenbereiche gedehnt, in der A-Lagerung werden die oberen Bereiche der Lunge gedehnt. Beide Lagerungen können bei dem Betroffenen zu einer deutlichen Atem erleichterung führen
- Die T-Lagerung führt zu einer weit reichenden Dehnung aller Bereiche der Lunge. Diese Lagerung ist für viele Betroffene eher ungewöhnlich, sie sollten daher in den ersten Minuten dieser Lagerung betreut werden
- 30°-Seitenlage und 90°-Seitenlage: Bei der Lagerung auf einer Seite wird die jeweils freiliegende Brustkorbseite besser belüftet. Wenn hier zusätzlich der obere Arm frei gelagert wird, verstärkt sich der Effekt zusätzlich

Langfristige Maßnahmen:

Längerfristige Maßnahmen zur Atem erleichterung werden immer mit dem behandelnden Hausarzt besprochen.

- Der Bewohner soll gegen einen Widerstand ausatmen
- Nutzung von Atemtrainern, wie z.B. den „Tri-flow-meter“
- Atemstimulierende Einreibungen zur Unterstützung der Sekretentleerung (Diese Form kann gut bei der Grundpflege mit eingebracht werden)
- Ggf. Beratung geben, um das Rauchen einzustellen
- Motivation und Anleitung geben zu körperlichen Aktivitäten, jedoch ist darauf zu achten, dass der Bewohner sich nicht übermäßig anstrengt

Weitere Maßnahmen:

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	3	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIE LEBEN WERTSCHÄTZUNG	Notfallstandard Atemnot	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Auswertung der durchgeführten Maßnahmen zur Atem erleichterung. Bei der nächsten Atemnot werden die Maßnahmen, die die Atmung erleichtert haben, bevorzugt eingesetzt
- Wenn sich die Attacken häufen, wird umgehend der Hausarzt in Kenntnis gesetzt, um eine Therapie auszuweiten, ggf. Vorstellung beim Lungenfacharzt anregen
- Die Pflegekräfte müssen darauf achten, dass der Bewohner Bewegung vermeidet, denn dies setzt die körperliche Belastbarkeit herab und somit setzt die Atemnot bei immer geringerer Belastung ein
- Sollte die Atemnot eine allergische Reaktion auf bestimmte Stoffe sein, wird der Kontakt zu diesen Stoffen auf ein Minimum reduziert
- Ist die Atemnot eine Folge einer Pneumonie (Lungenentzündung), wird der Standard Pneumonie umgesetzt. Je nach Anordnung des Arztes wird hier eine Antibiotikatherapie durch die Pflegekräfte gewährleistet
- Es kann durch den Sauerstoffmangel zu Verwirrheitszuständen bei dem Bewohner kommen, in denen sich eine Desorientiertheit bemerkbar macht. Hier ist der Bewohner besonders zu betreuen
- Vermeidung von Isolation des Bewohners. Eine Isolationsgefahr besteht häufig, weil der Bewohner Anstrengung und Aktivitäten vermeiden will und somit die sozialen Kontakte nachlassen

Dokumentation:

Dokumentiert wird unter:

- Berichteblatt
- Ärztliche Kommunikation
- Vitalwerte
- Ggf. Ärztliche Verordnung
- Ggf. Pflegeplanung/Maßnahmenplan
- Ggf. Schmerzprotokoll

Zu dokumentieren sind z.B.:

- Wie lange dauerte der Anfall?
- Subjektives Empfinden des Bewohners bzgl. des Anfalls? Klagte er zum Beispiel über Erstickungsangst?
- Welche Vitalwerte wurden gemessen? Insbesondere die Pulsfrequenz
- War die Atmung „pfeifend“?
- Wie war die Hautfarbe des Bewohners? War er zyanotisch?
- War die Atemfrequenz z.B. verlangsamt, erhöht oder unregelmäßig?
- War der Bewohner kaltschweißig?
- Kam es zu einer Bewusstseinsstörung? War der Bewohner desorientiert?

Durchführungsverantwortlichkeit / Qualifikation:

- Alle Pflegekräfte

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	4	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LERNEN WERTSCHÄTZUNG	Notfallstandard Atemnot	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, QMB, stellvertretende PDL, Wohnbereichsleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	5	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.